

Brain & Mind

Morning Conference Case

이름대기장애로 내원한 72세 여성
왕민정 / 로아신경과의원

2년 전부터 시작된 이상행동을 주소로 내원한 55세 여성
양영순 / 순천향대학교 천안병원

말더듬을 주요 호소 증상으로 내원한 68세 남성
장재원 / 강원대학교병원

이름대기장애로 내원한 72세 여성

증례

72세 여성이 1년 전부터 시작되어 악화되는 기억력 및 이름 대기장애로 내원했다. 약 1년 전부터 기억력이 서서히 저하되었고, 언어능력은 최근 두드러지게 저하되었다고 했다.

자기가 둔 물건을 찾지 못하는 경우가 드물게 있지만, 중요한 일과 약속은 잘 기억하는 편이고, 약 복용이나 은행업무 처리, 집안 살림 등은 독립적으로 가능했다. 그러나 언어능력 중 단어가 빨리 생각이 안 나고, 말 전달이 느리며, '그거', '이거' 등 대명사를 많이 사용한다고 했으며, 단어를 혼동하여 '문재인 대통령 -> 노무현 대통령' 이라고 하거나, 간혹 대화 중 내용 이해가 되지 않아 반복적으로 질문하기도 했다.

인지기능 및 언어능력 평가를 위해 Seoul Neuropsychological Screening Battery (SNSB) 및 한국판 보스턴 이름대기 검

사(Korean version-Boston Naming Test, K-BNT) 및 한국판 웨스턴 실어증 검사(Korean version-Western Aphasia Battery, K-WAB)를 시행했다.

간이정신상태검사(Korean version of Mini-Mental State Examination, K-MMSE)에서 26/30점으로 장소지남력(-1점), 기억회상(-2점), 이름대기(-1점)에서 저하가 관찰되었다. SNSB 검사 결과, 언어능력 중 대면 이름대기능력이 최하 수준으로 저하되었고, repetition ability의 저하도 관찰되었다. 시공간 지각 분석 능력은 평균 수준으로 유지되고 있으나, 심적 표상의 시구성능력은 경계선 수준으로 저하되었다. 또한 언어적 기억력 중 단어의 학습과정은 평균이하 수준에서 장상적으로 유지되고 있으나, 단어를 인출하는 과정이 저하되었다. 전두실행기능 중 mental set formation & shifting ability, motor

coordination ability, word generative naming flexibility의 저하도 관찰되었다. 따라서 Lt. parietal lobe, bilateral basal forebrain, frontal lobe function의 저하가 관찰되었으며, CDR 0.5 (SOB 2.0), GDS 3점으로 일상생활에 지장을 받는 정도는 아니었다(그림 1).

한국판 웨스턴 실어증 검사 결과 실어증 지수(aphasia Quotient, AQ)는 83.8점으로 정도의 전도 실어증(conduction aphasia)의 양상을 보였다(그림 2). 검사 상 스스로 말하기에서 5~6 어절을 이어 말하기가 가능하고, 내용도 적합했으나, 낱말 찾기의 어려움이 자주 관찰되었다. 복잡한 문장에 대한 이해력도 비교적 유지되었으나, 복잡한 명령이행을 제대로 수행하지 못했으며, 따라말하기에서 음소착어가 빈번했다. K-WAB 검사에서는 사물 이름대기 수치가 정상범위이나 음소, 의미 착어가 빈번했

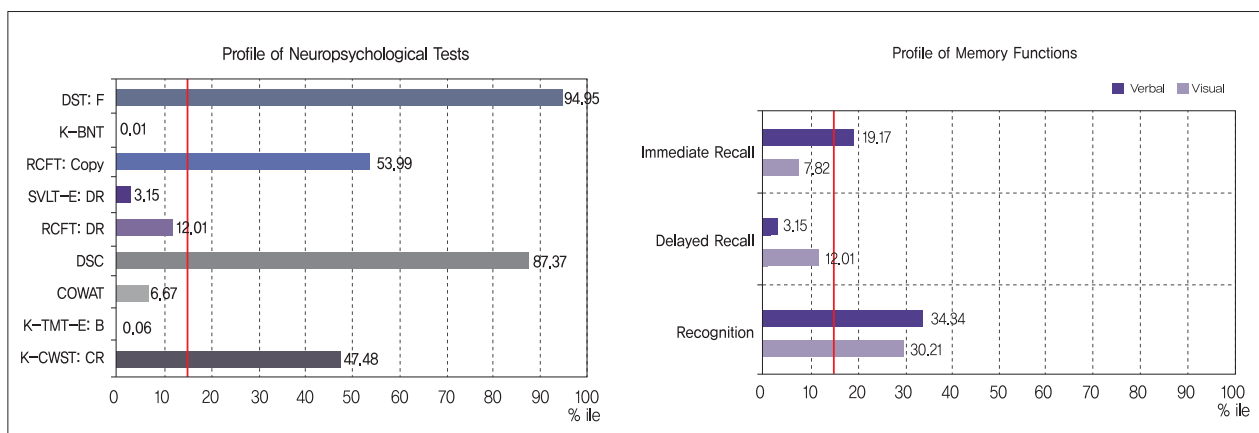


그림 1. SNSB 결과표.

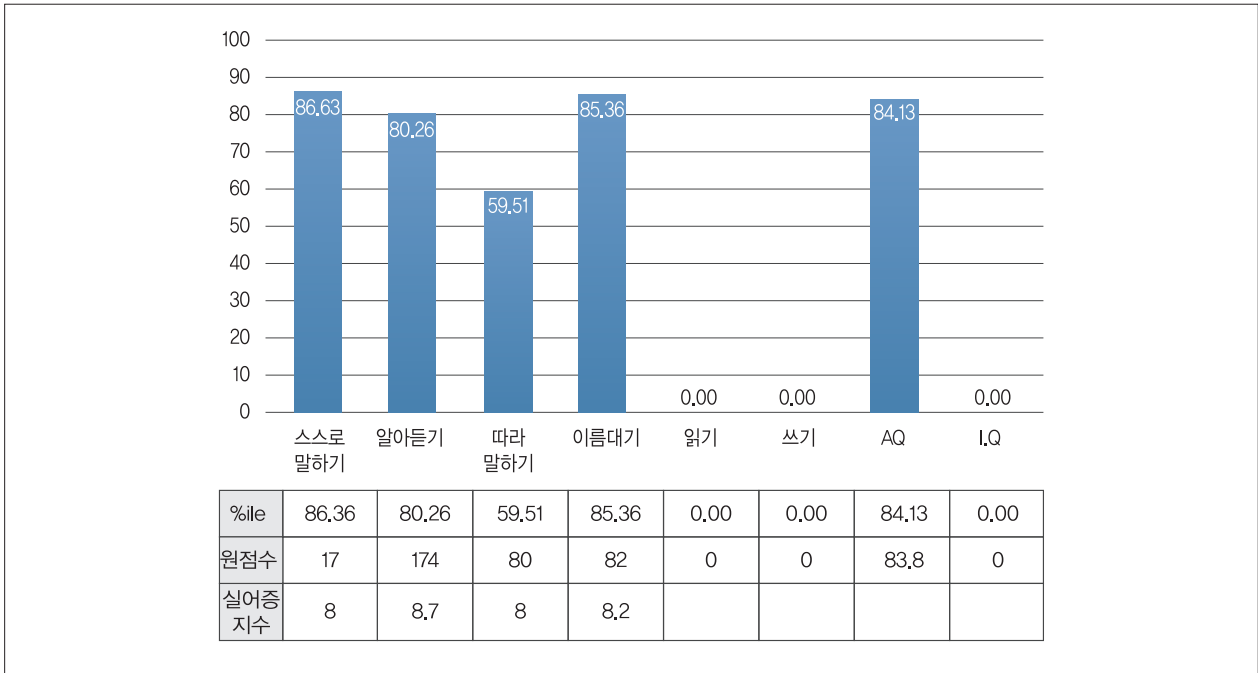


그림 2. K-WAB 결과표.

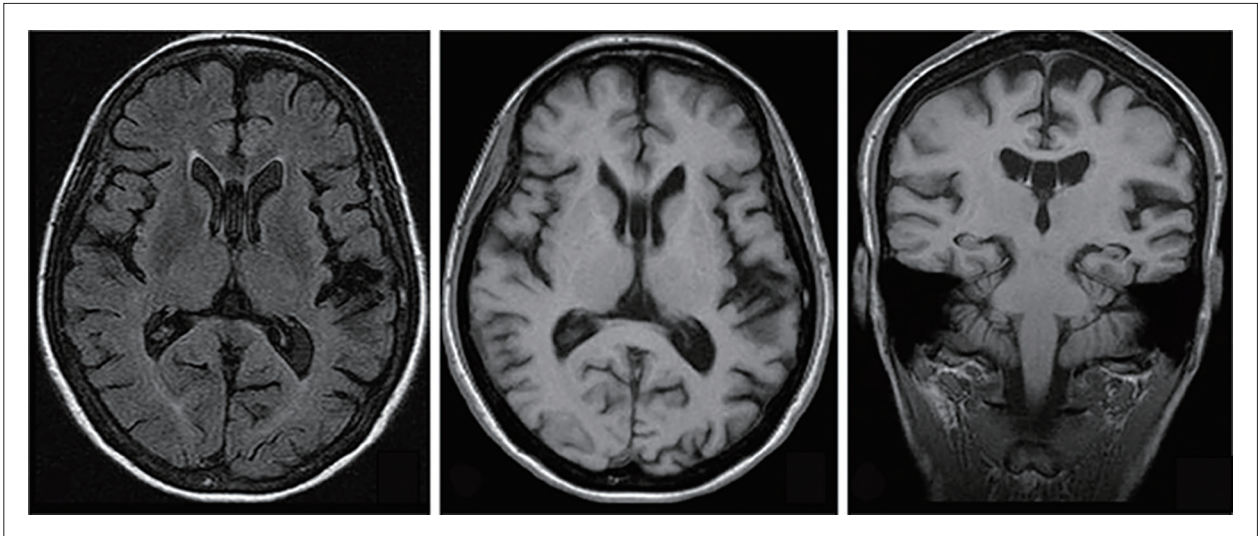


그림 3. MRI 영상결과.

다. 비교적 난이도가 어려운 K-BNT 검사에서 이름대기 능력이 최하 수준으로 저하되었고, 나침반을 보고 ‘세상을 저기 하는 라이트’, 야자수는 ‘더운 곳에 있는 야수’ 등

으로 표현하는 모습이 관찰되었다.

환자의 brain MRI에서는 좌측 상, 중간 측두이랑 및 하부 두정엽의 위축이 경하게 관찰되었다(그림 3). 환자는 다른 인지장애

에 비해 언어장애가 뚜렷하며 서서히 진행되는 퇴행성 뇌질환이 의심되었으며, 단어 결핍실어증(logopenic variant, PPA-L)으로 진단했다.

고찰

진행성 언어장애를 보이는 퇴행성 뇌신경 계질환(primary progressive aphasia)은 임상증상에 따라 크게 의미치매(semantic dementia, PPA-S)와 진행성 비유창성 실어증(progressive non-fluent Aphasia, PPA-G), 단어결핍 실어증(logopenic variant, PPA-L)으로 분류된다 (그림 4).¹

이 환자는 단어 및 기본적인 문장 발화 및 단어 의미, 유창성은 상대적으로 보존되어 있으나, 반면에 말의 속도가 느리고, 긴 문장의 이해나 따라 말하기는 어려움이 있었다. 전형적인 PPA-S 환자에 비해 유창성이 다소 저하되어 있으나, 전형적인 PPA-G 환자와 비교하면 훨씬 유창하며,

힘들어하면서 더듬는 발화는 없었다. 따라서, 다른 인지영역에 비하여 언어장애가 뚜렷한 점, 일상대화에서 유창성과 기본적인 단어의 의미와 문장 이해는 상대적으로 보존되어 있으나 음소 착어가 종종 관찰되고 따라 말하기의 장애, 발화 속도가 다소 느리고, 긴 문장의 이해가 어려운 점을 고려하여 PPA-L에 해당하다고 판단했다.

PPA-L의 병리적 원인은 아직 분명하지 않으나, PPA의 다른 아형과는 달리 알츠하이머병(AD)의 병리와 관련이 있다는 연구들이 다수 보고되었다. 그로스만²이 요약한 부검 확인 사례에 따르면, 부검 시 PPA-L에서 가장 빈번하게 발견된 것은 AD 병리로, 24건 중 12건(50%)에서 관찰되었고,

FTLD-TDP 병리는 9건(38%)에서 확인되었으며, 소수의 환자가 FTLD-tau 병리(n=3)로 확인되었다. 또한 PPA-L 환자들을 대상으로 시행한 뇌 MRI와 뇌 SPECT 영상에서는 Lt, superior & middle temporal gyrus 및 Lt, inferior parietal lobule의 위축과 대사 저하가 확인되어 PPA-G나 PPA-S에서 주로 손상되는 Lt, fronto-insular area 및 Lt, anterior temporal area와는 차이가 있음을 보였다.^{3~5}

PPA-L의 정확한 임상적 진단을 위해서는 PPA의 다른 아형 및 기타 퇴행성 뇌질환들과 구별되는 언어장애의 특징을 확인하는 것이 우선적으로 필요하며, 기본적인 정밀 인지 검사 외에 K-WAB 등의 추가적

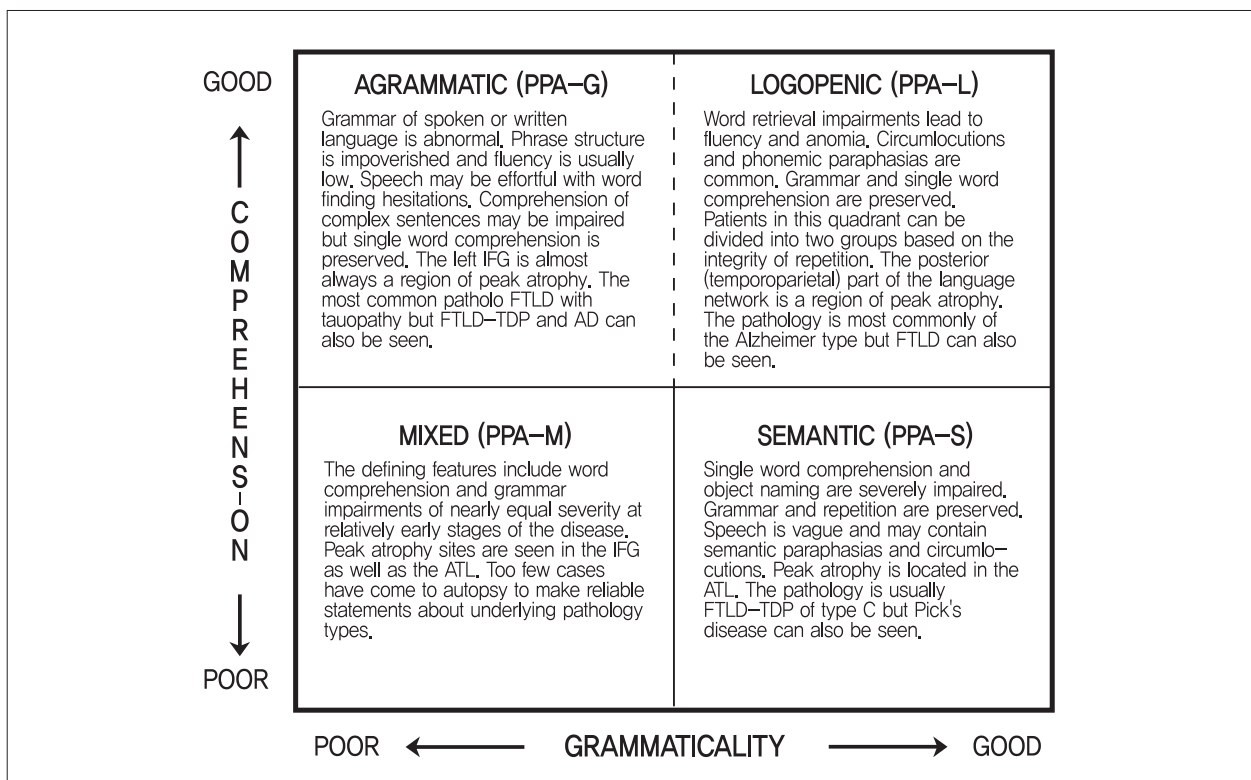


그림 4. A 2-dimensional template for the rapid clinical classification of PPA patients. PPA-G, PPA-L, PPA-M, PPA-S- agrammatic, logopenic, mixed and semantic variants of primary progressive aphasia.¹

표 1. Characteristics of PPA variants.⁶

Variant	Clinical features	Cortical atrophy	Pathology ^a	Alternative nomenclature
lvPPA	• Impaired single word retrieval • Impaired repetition of phrases and sentences • Three or more of the following: speech sound errors; spared motor speech; spared single word comprehension and object knowledge; absence of agrammatism	Left posterior perisylvian; inferior parietal	• AD (50%) • FTLT–TDP (38%) • FTLT–tau (12%)	• Logopenic progressive aphasia or LPA • Logopenic PPA or PPA–L • Progressive mixed aphasia or PMA

인 언어 검사와 그리고 구조적, 기능적 뇌 영상 검사의 확인이 필요할 것으로 사료된다.

Reference

1. M. Marsel Mesulam, Primary Progressive Aphasia and the Left Hemisphere Language Network Dement Neurocogn Disord 2016;15(4):93–102.

2. Grossman M. Primary progressive aphasia: clinicopathological correlations. Nat Rev Neurol 2010;6:88–97. [PubMed: 20139998] This paper summarizes the autopsy–confirmed pathology results from 145 PPA patients across seven institutions. The current findings for neuropsychological, neuroimaging, genetic, and cerebrospinal fluid biomarkers of the PPA variants are reviewed.

3. Gorno–Tempini ML, Brambati SM, Ginex V, Ogar J, Dronkers NF, Marcone A, et al. The logopenic/phonological variant of primary progressive aphasia. Neurology 2008; 71: 1227–34.

4. Mesulam M, Wieneke C, Rogalski E, Cobia D, Thompson C, Weintraub S. Quantitative Template for subtyping primary progressive aphasia. Arch Neurol 2009; 66: 1545–51.

5. Henry ML, Gorno–Tempini ML. The logopenic variant of primary progressive aphasia. Curr Opin Neurol 2010; 23: 633–7.

6. Michael F. Bonner, The New Classification of Primary Progressive Aphasia into Semantic, Logopenic, or Nonfluent/Agrammatic Variants, Curr Neurol Neurosci Rep. 2010 November ; 10(6): 484–90.

2년 전부터 시작된 이상행동을 주소로 내원한 55세 여성

증례

55세 여성이 2년 전부터 서서히 발생한 이상행동장애를 주요 호소 증상으로 병원에 왔다. 오른손잡이이고 고등학교 졸업의 학력으로 슈퍼마켓을 운영하고 있다. 최근에 본인이 했던 행동을 부인하며 화를 내는 일이 잦았으며, 마트에서 고객들과 마찰이 있어 마트 운영에 어려움을 겪고 있었다. 계산 시 물건의 명칭을 잊어 계산 실수가 반복되었다. 환자는 내원 2년 전부터 물건 이름이나 잘 아는 사람의 이름을 떠올리지 못하는 증상을 호소했다. 내원 1년 전부터는 상대방의 말을 잘 알아듣지 못하고 친구들의 얼굴을 잘 알아보지 못하는 일이 잦아지자 가족들이 이상하게 여기기 시작했다. 알고 지내던 동네 사람들에게 인사를 하지 않아 오해를 사는 일이 발생하고, 마트에서 손님이 과일을 달라고 하면 이름이 무엇인지 몰라 손님에게 자주 묻는 증상이 생겼다.

발병 전 성격은 비교적 원만한 편이었으나, 최근 1년 전부터는 고집이 세지고, 화를 잘 내는 경향이 생겼으며, 주변 일에 대해 관심이 없는 모습을 보이기 시작했다고 한다. 그리고 금방 들었던 말이나 이야기를 잊어버리고 자주 되묻는 현상이 빈번해졌다. 그러나 일상적인 생활을 하는 데는 아무런 장애가 없었고, 길을 잃거나 집을 못 찾는 증상은 없었으며, 내원 당시에

도 운전은 직접 할 정도였다. 계산 능력에도 이상이 없어서 집에서 가계부 작성도 혼자서 하고, 은행 계좌 관리도 본인이 직접 하고 있는 상태였다. 환자는 면담 시 매우 비협조적이었으며 낱말 찾기 어려움 때문에 가끔 머뭇거림이 있었으나 긴 문장을 매끄럽게 구사할 수 있었고 유창한 편이었다.

기저 질환으로 당뇨병이 있으며, 치매의 가족력은 없었다. 술이나 담배는 하지 않았다. 신경학적 검사상 의식은 명료하였으며, 뇌신경, 운동기능 및 감각기능 검사는 정상 소견이었다. 건반사에서도 이상소견 없었으며, 병적 반사도 관찰되지 않고, 소뇌기능 검사와 보행도 정상이었다.

신경심리검사 시 숫자 따라 말하기는 5자리까지 가능했고, 거꾸로 말하기는 2자리 가능했다. 실행증 검사, 좌우지남력 검사에서 이상 소견은 없었고, 전두엽기능장애(주먹-손날-손바닥 장애)를 보였다.

시공간능력은 유지되어 있었다. 단어의 뜻을 이해하지 못해 정확한 반응을 보이지 못하는 경우가 많았다. 예를 들면 “취미 생활이 뭐니까?”라고 물었을 때, “취미 생활?”, 취미가 뭐니까?”라고 되물었으며, ‘예, 아니오’ 검사에서 물어보는 질문의 뜻을 이해하지 못해 정확한 반응을 보이지 못했고, 형태나 색깔, 그리고 실물 그림을 제시했을 때 낱말을 정확히 표현하지 못했

다. 환자는 대화 도중 의미착어증을 자주 보였다. 예를 들어 ‘의사’를 ‘사장님’이라고 하고 ‘사감’을 ‘회장’이라고 표현하곤 했다.

일반 화학, 일반 혈액, 매독, 갑상선 기능 검사상 특이 소견은 없었고 apoE 검사에서 e3/e3 관찰되었다. MRI 상 양측 측두엽 위축이 관찰되었다(그림 1).

자세한 신경심리검사는 환자의 성격 변화로 협조가 불가해 진행하지 못했고, 한국판 간이정신상태검사(Korean-Miini Mental Status Examination-2, K-MMSE-2): 20점, CDR: 1로 관찰되었다. 이 결과를 종합해 의미치매로 진단 내릴 수 있었다.

고찰

의미치매는 행동변이성 전두측두치매와 진행성 비유창성 실어증과 더불어 전두측두엽치매의 한 아형이다. 해부학적으로 전두측두치매는 전두엽과 측두엽을 침범하는 질병임에 비해, 의미치매는 측두엽만을 침범하므로 측두엽 변이라 불린다. 즉, 의미치매는 전방측두엽의 국소 위축으로 인해 점진적으로 사물에 대한 개념과 의미를 소실함을 특징으로 하는 퇴행성 질환이다.

의미치매의 병변은 병의 초기에 측두엽의 전방부에만 국한되어 있고, 그 분포가 매우 비대칭적이다. 즉 어떤 환자는 좌측

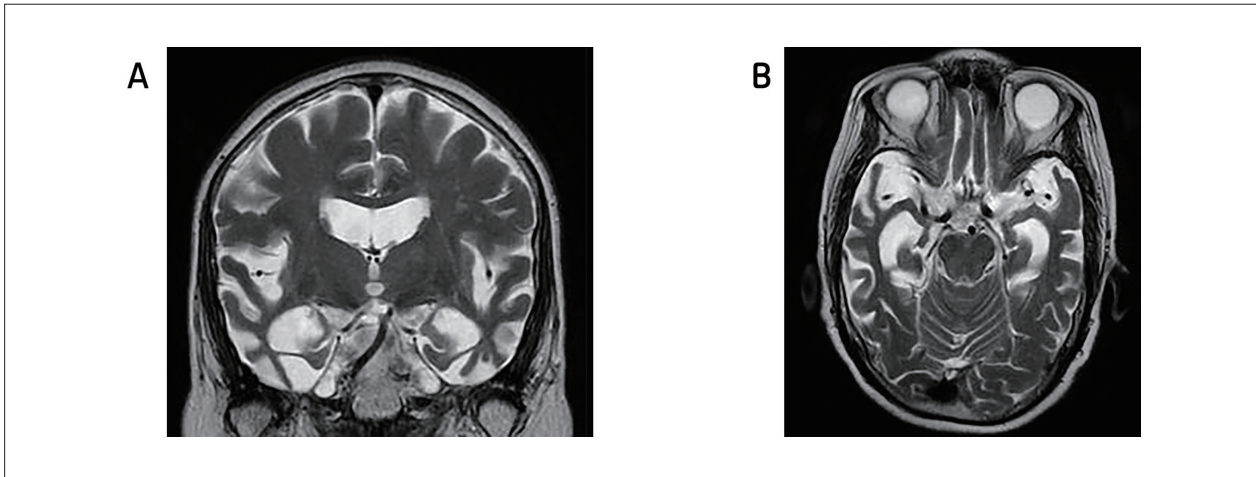


그림 1. Magnetic resonanace imaging of the patient. Coronal T2 (A), Axial T2(B) sequences of the patient represent ant. Temporal atrophy.

측두엽에, 어떤 환자는 우측 측두엽에 주 병변이 있다. 전자의 경우는 명사를 말하지 못하거나 알아듣지 못하는 언어 장애로 시작하고, 후자의 경우에는 얼굴을 잘 알아보지 못하는 증상으로 시작한다. 이유는 잘 모르지만 전자의 환자가 훨씬 많다.

왜 ‘의미치매’라는 말이 붙여졌을까? 우리가 ‘사과’라는 단어를 들으면 사과에 대한 의미(semantics), 즉 ‘달다’, ‘시다’, ‘빨

갓다’, ‘과일’ 등 여러 의미가 떠오르게 된다. 하지만, 좌측 측두엽 위축이 심한 의미치매 환자들에게 ‘사과’라는 말을 들려주면 “사과라는 말을 많이 들어본 것 같은데, 무슨 말인지 모르겠다”라고 대답한다. 즉 단어의 ‘의미’를 모른다고 하여 ‘의미치매’라고 붙여진 것이다. 마찬가지로 우측 측두엽 병변이 심한 의미치매 환자에게 병전에 잘 알던 얼굴(예를 들어 대통령 얼굴)을 보

여주면, 남자인지 여자인지 나이가 많은지 적은지는 구별하지만 그가 누구인지를 모른다(이런 현상을 얼굴실인증이라고 부름). 즉, 얼굴의 의미를 모르는 것이다. 젊은 나이의 환자에서 기억력 보다는 명칭 실어증 및 알아듣기 능력이 나빠진다면 의미치매를 의심해 봐야 할 것이다.

말더듬을 주요 호소 증상으로 내원한 68세 남성

증례

68세 남성이 약 3개월 전부터 서서히 발음이 어눌해지고, 말문이 자주 막힌다며 기억장애 클리닉에 방문했다. 오른손잡이이고 고등학교를 졸업했다.

내원 3개월 전부터 말을 더듬게 되고 특히 빨리 말하려고 하면 생각이 나지 않는다고 호소했다. 단어도 잘 생각이 나지 않게 되었으나 가족들이나 주변사람들은 인지하지 못한다고 했다. 이해력에는 문제가

없었으며 스스로 느끼기엔 이전일을 생각하려고 하면 기억이 나지 않는다고 했다. 최근에는 글을 쓰기가 어려워지는 것 같다고 했으나 길 찾기는 문제가 없었고, 기본적인 위생 관리, 사회활동에도 문제가 없었다.

복용 중인 약물은 없었으며 술, 담배는 하지 않고 치매나 뇌졸중의 가족력은 없었다.

신경학적 진찰 시 말 장애(speech disorder)

이외에 뇌신경 검사상 이상은 없었고, 사지의 근력, 근육의 긴장도, 사지의 몸감각기능은 정상이었다. 팔림이나 불수의운동은 관찰되지 않았으나, 미세한 동작을 시켰을 때 오른손이 왼손에 비해 약간 둔해져 있었다. 우측 상지에서 시행된 두 점 식별, 입체감각 인식, 피부그림각각 검사에서는 정상 반응을 보여 피질감각저하는 없었다. 심부전반사에서 이상소견 보이지 않았으며 병적반사도 없었다. 보행 시 이상 없었으며 소뇌기

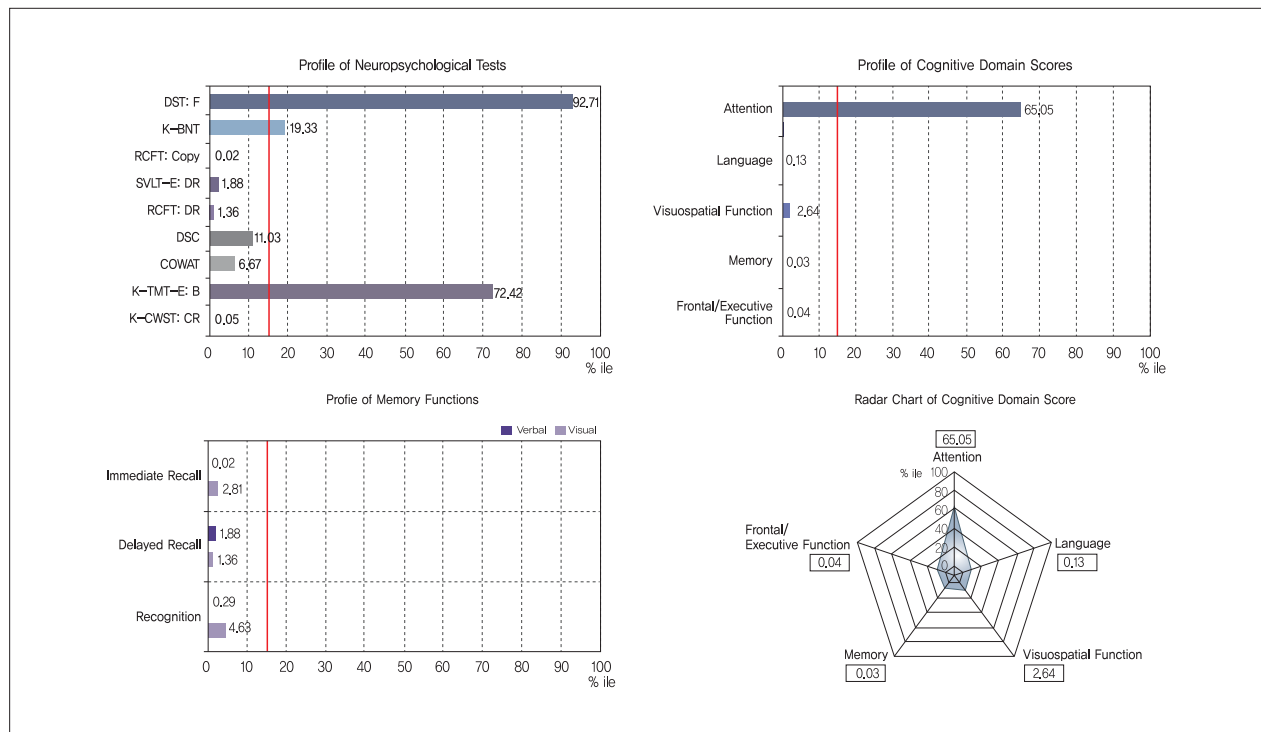


그림 1. 서울신경심리검사(SNSB).

능은 정상이었다. 한국판간이정신상태검사(K-MMSE)에서는 계산, 기억등록, 오각형 그리기에서 오류를 보여 총 30점 중 25점을 얻었다.

환자의 신경심리검사 결과를 (그림 1)에 제시하였다. 주의력영역에서 숫자 외우기 검사(digit span test)의 경우, 숫자 따라 말하기(digit span test: forward) 8개로 단순 주의력은 양호했으나 숫자 거꾸로 따라 말하기(digit span test: backward) 3개로 수행이 저하되어 원점수 차이가 5점으로 작업 기억력의 이상을 보이고 있었다. 언어 및 관련 검사에서는 손가락 이름 대기에서 새끼손가락을 “쪽지 손가락”이라고 하여 착어가 나타나고 있었다.

시공간능력검사로는 레이복잡도형검사(Rey complex figure test, RCFT)에서 세부적인 도형의 정확한 묘사의 어려움, 생략 등이 나타나 전체적인 조직화가 잘 안 되는 시공간 구성능력의 문제가 시사되고 있었다.

언어기억검사인 서울 언어학습검사(Seoul verbal learning test, SVLT)의 즉각회상 과제 수행 시 3번의 시도에서 각각 2개, 1개, 2개(0.02 percentile)를 말했고, 20분후 지연회상 과제에서는 2개를 기억했다(1.88 percentile).재인 검사에서도 진양성 5개, 위양성 1개로 재인지수(recognition index) 4(0.32 percentile)로 언어기억의 저장 장애가 시사되었다. 시각기억 검사를 위해 사용된 레이복잡도형검사에서는 즉각회상과 지연회상 및 재인검사 과제에서 모두 저조한 수행을 보여(2.81, 1.36, 4.76 percentile) 시각기억의 저장장애가 시사되었다. 전두엽진행검사에서는 contrasting program에서도 2

회 오류를 보였으나 go-no-go에서 현저한 어려움을 보여 억제(inhibition)의 문제가 있었다. 손교대운동검사(Alternating hand movement)도 어려움을 보여 운동틀전환(motor set shifting)의 어려움이 나타나고 있었으며, 루리아 고리(Luria loop)에서는 보속증이 의심되었다. 의미 및 음소 유창성(semantic & phonemic word fluency)은 경도로 저하되어 단어 산출의 어려움이 나타나고 있었으며, 스트룹검사(stroop test)에서도 단어-색깔 읽기 수행에서 저하(0.05 percentile)로 나타나 일부 전두집행기능의 저하가 나타나고 있었다.

임상치매척도(Clinical dementia rating, CDR)는 0.5, 바텔지표(bathel index)는 20점(만점)이었다. 도구적 일상생활 평정결과 돈 관리, 집안일하기, 장보기, 약복용, TV시청 등은 양호하였으나 최근 기억 저하가 나타나고 있었다(도구사용일상생활능력 평가 K-IADL 0.1). 신경심리검사를 종합해 보면 일부 언어 관련 능력, 시공간 구성능력, 언어 및 시각 기억력, 전두집행기능의 문제가 있으며 아직은 일상생활을 독립적으로 유지하고 있는 기억형 다영역 정도인지장애에 부합했다.

하지만, 환자는 주요 호소증상으로 지속적인 말장애를 호소하며, 신경심리 검사와 부합하지 않는 측면이 있어 추가로 한국판웨스턴실어증검사(PARADISE Korean Western Aphasia Battery, K-WAB)를 시행했다. 언어표현력 측면에서 스스로 말하기의 경우 내용의 전달은 비교적 양호한 편이었으며, 그림의 다양한 상황들을 설명할 수 있었고, 최대 5어절의 문장까지 사용하는 모습을 보였다. 그러나, “쪽배”를 “뚝배”라고 발음하는 음소 착어가 1회 나

타났다. 이해력 측면에서 총 20문항의 예/아니오 검사에서 환자 자신의 성별에 대한 응답 오류가 1회 있었으나 전반적으로 낱말의 인지도 양호하여 알아듣기의 어려움은 시사되지 않았다. 따라말하기는 15개의 문항 모두 완벽하게 따라 말하는 것이 가능했다. 사물의 이름대기, 문장의 완성이나 응답은 매우 양호했으나 의미 단어 유창성은 9개만을 이야기 하는 등 어휘적 유창성은 다소 감소되어 있었다. 스스로 말하기 19/20, 알아듣기 9.5/10, 따라말하기 10/10, 이름대기 8.9/10으로 총 실어증지수(aphasia quotient, AQ)는 92.8로 확인되었다.

일반혈액 검사, 일반화학 검사, 요 검사, 혈액응고 검사 등은 모두 정상이었으며 갑상선기능 검사, 비타민 B12, 엽산 수치도 정상 수준이었고, 흉부방사선촬영, 심전도도 정상이었다. 아포지단백 유전형 검사에서는 e3/e4의 유전형을 보였다. 뇌자기공명영상(MRI) 영상에서는 우측에 비해 좌측의 실비우수열 주변이 위축되어 보였으나 뚜렷하진 않았다(그림 2).

FDG 양전자방출단층촬영(PET)에서는 좌측전두-측두엽과 두정엽의 대사 감소가 관찰되었다(그림 3).

신경심리검사 상 저장형 기억력장애 및 시공간 구성능력 장애를 보여 알츠하이머병 감별을 위해 시행한 아밀로이드 PET 검사 상에서는 이상 소견 보이지 않았다(그림 4).

주요 증상과 영상 소견을 바탕으로 비유창/비문법변이원발진행실어증(Non-fluent/agrammatic variant primary progressive aphasia)으로 진단 후 외래 추적 관찰했으며, 이후 추적 관찰 기간 중

에 언어장애가 심해졌다. 말수가 줄었으며 ‘바나나’를 ‘파인애플’, ‘작살’을 ‘꽃삽’이라고 반응하는 의미 착어증을 보였다. ‘새끼 손가락’을 ‘검지’라고 반응하고, ‘가운데손

가락’을 ‘약지’라고 반응하며 손가락 명칭에 혼동하는 모습을 보였다. 급하게 말을 하려다 보면 욕이 나올 때가 있다고 했다. 이전 같으면 화가 안 날 일에도 화가 난다

고 했으며 우울감도 늘었다. 글씨 쓰기도 점점 힘들어져서 글씨를 알아보기가 어려워졌다. 사람이나 사물의 이름이 생각나지 않아서 “그거”와 같이 대명사를 사용하는

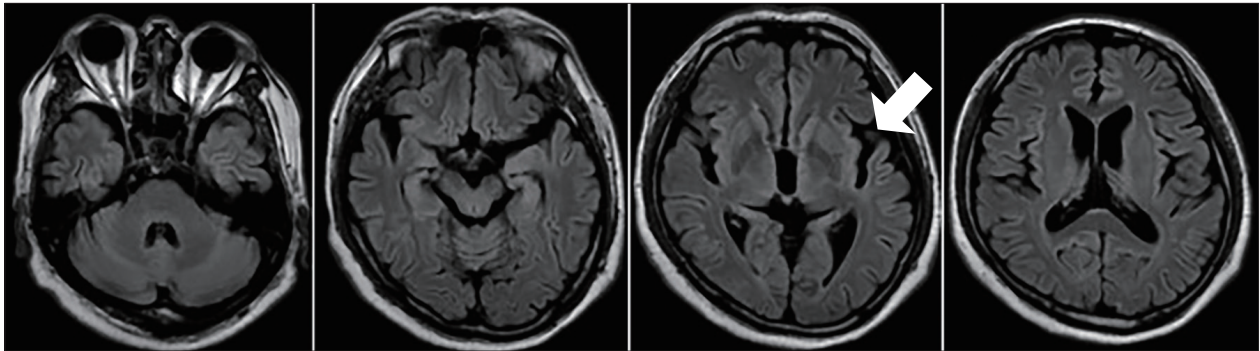


그림 2. Brain MRI, T2 FLAIR, 좌측 실비우스열 주변의 경미한 위축이 관찰되고 있다.

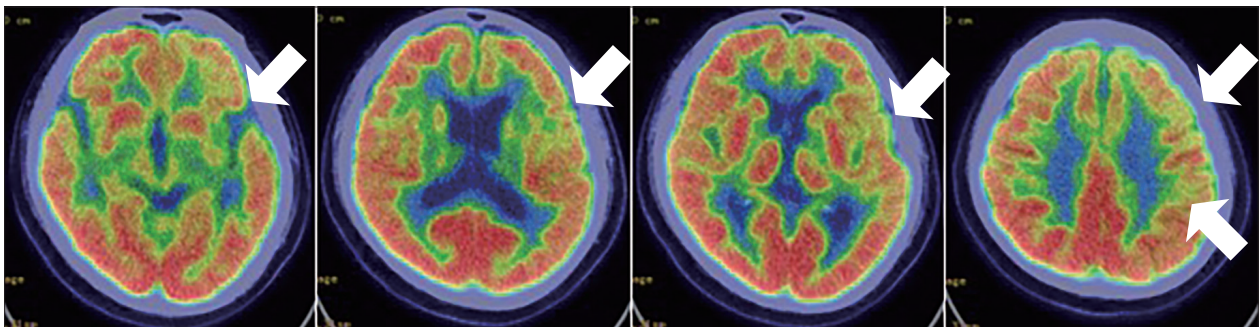


그림 3. FDG-PET 검사. 우측에 비해 좌측 전두엽, 측두엽, 두정엽의 대사 저하가 관찰된다.

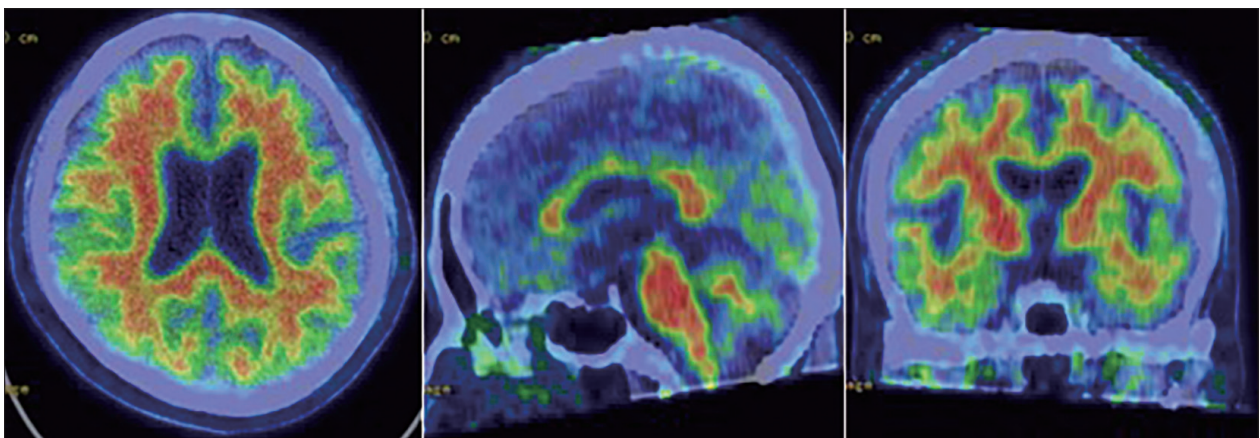


그림 4. 아밀로이드 PET. 아밀로이드는 검출되지 않았다.

경우가 많아졌으나 병원에 가는 것을 기억하는 것과 물건을 둔 장소는 비교적 잘 기억하며 뉴스 시청에 대한 이해도 좋은 편이었다.

고찰

상기 환자와 같이 말이 어눌해 기억장애 클리닉을 방문할 경우 말 장애(speech disorder)와 언어장애(language disorder)를 구분하는 것이 필요하다. 말 장애는 말의 집행이나 프로그램의 장애를 의미하며, 언어장애는 표현과 이해에 문제가 있는 것이다. 예를 들면 루게릭병의 일종인 진행성 뇌마비의 경우 운동신경의 문제로 근육의 위약이 발생하여 말이 어눌해지는 말 장애의 대표적 감별질환으로 고려가 필요하다. 이러한 말 장애는 일정한 발음에 문제가 생기는데 비해 언어장애의 경우 일정한 발음에 문제가 생기지는 않는다. 또한 언어 장애 환자의 경우 말 장애와 달리 이해력, 문법 오류, 쓰기 장애가 동반될 수 있다.

증례와 같이 말이 어눌하거나 언어의 문제가 보이는 환자가 방문해 퇴행성 뇌질환이 추정된다면 원발진행실어증을 의심하고 비유창/비문법변이, 의미변이, 로고페닉변이 원발진행실어증을 감별하는 것이 필요하다. 상기 환자는 초기에 발음의 문제와 단어 찾기 어려움만 관찰되었으나 추적 관찰을 하면서 말수가 줄고 착어증 및 이름대기 장애도 악화되었다. 초기에는 유창성이 어느 정도 유지가 되어 있으므로 로고페닉변이 원발진행실어증과 감별이 쉽지 않다. 반면에 의미변이 원발실행증은 초기에 환자의 스스로 말하기는 매우 유창하고 머뭇거림이나 말 끊김 현상을 보이지

않으므로 본 증례 환자와는 차이를 보였다. 언어장애가 주 증상으로 원발진행실어증의 가능성을 생각하였고, 아형 중 유창성의 저하를 특징으로 하는 비유창/비문법변이로 진단했다.

비유창/비문법변이 원발진행실어증의 핵심 증상 두 가지는 문법의 오류와 말실행증인데 초기 단계 K-WAB에서는 확인되지 않았다. 병이 진행하면서 뚜렷한 문법의 오류와 말실행증도 동반되었으나 K-WAB을 추적관찰하지 못한 부분은 본 증례의 제한점이다.

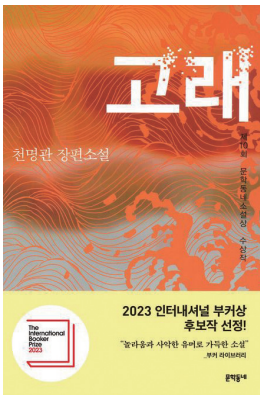
영상 소견은 MRI에서는 경미한 실비우스열 주변의 위축이 추정되며 FDG-PET에서 좀 더 명확하게 좌측 전두-측두엽과 두정엽의 대사 저하를 보이고 있어 비유창/비문법변이 원발진행실어증에 해당한다고 판단했다.

비유창/비문법변이 원발진행실어증 환자에서 확인할 부분이 이상운동증 발생 여부이고, 상기 환자는 미세한 동작을 시켰을 때 오른손이 왼손에 비해 둔해져 있었으나 떨림이나 불수의 운동은 초기엔 관찰되지는 않았다. 하지만, 추적 관찰 하면서 젓가락질도 힘들어지고 글자 쓰기도 어려워졌으며, 동작 완만도 발생해 파킨슨 증상이 동반되었다. 병리학적으로 비유창/비문법변이 원발진행실어증 환자의 경우 60% 정도가 타우병증을 보이고 상기 환자처럼 이상운동증이 동반된 경우 피질기저핵변성과 진행핵상마비에 해당한 병리를 보일 수 있다. 치료는 말하기 치료를 기반으로 한 언어치료와 파킨슨 증상에 대한 치료를 시도할 수 있다.

BOOK GUIDE

고래

저자: 천명관, 출판사: 문학동네



지난 2004년 제10회 문학동네소설상 수상작. 2023년 인터내셔널 부커상 후보작에 오르면서 재조명 받고 있는 소설이다.

‘고래’는 신화적, 설화적 세계에 가까운 시·공간을 배경으로 한다. 소설의 1, 2부에서는 산골 소녀에서 소도시의 기업가로 성공하는 ‘금복’의 일대기와 주변 인물들의 천태만상이 그려진다. 3부는 감옥을 나온 뒤 폐허가 된 벽돌공장에 돌아온 금복의 딸이자 정신박약아인 ‘춘희’의 삶을 담고 있다. “이 모든 이야기가 한 편의 복수극”이라는 작가의 말대로 소설의 시작부터 끝까지 한을 품고 죽은 박색 노파가 등장, 주인공을 파국으로 이끈다는 설정이다.

조각조각, 수십 개의 에피소드가 꼬리에 꼬리를 물고 이어진다. ‘세상에 떠도는 이야기’들을 모두 모아놓은 양 할아버지 할머니한테 들던 옛날 이야기, 동화책에서 본 설화와 신화, TV 연속극 같은 스토리, 인터넷에 떠도는 엽기 유머 등이 섞여든다.

만몽으로 시작해 큰 사업가가 된 한 사람의 이야기인가 싶으면 벽돌을 굽는 한 장인에 대한 이야기이고, 다시 여러 시대를 살다 간 인물들의 지난 세기의 이야기인가 하면 바로 오늘날의 이야기이기도 하다.

폭풍우처럼 격렬하고 파괴적인 인간의 ‘욕망’을 그린 천명관의 소설은 인물의 내면과 공간의 묘사를 배제한 채 시나리오 기법에 의존함으로써 빠른 속도로 읽힌다. 살인과 폭력, 죽음의 음산함, 전통설화의 세계, 질편한 해학과 유장한 판소리를 연상케 하는 능청스럽고 능란한 입담, 신파극 번사를 떠올리게 하는 과장된 감정분출과 유치한 이죽거림, 무협지나 성인만화의 한 장면을 떠올리게 하는 대목 등 다양하고 다채로운 자양분들을 치밀한 구성으로 한 작품 속에 녹여내고 있다.

문학평론가 류보선은 출간 당시 추천사에서 “이 소설에는 어떻게 보면 이야기의 백과사전 같은 느낌이 들 정도, 또는 구비문학자료집 같은 느낌이 들 정도로 아주 많은 이야기들이 있다. 물론 이것만이 아니다. 소설이나 영화, 드라마나 연극 등의 고급 장르로부터 엽기 시리즈, 농담, 야설, 포르노 등등 하위 장르에 이르기까지 기존의 것을 연상시키는 에피소드나 그것의 변주가 무궁무진하다. 말 그대로 이 소설은 장터의 시끌벅적한 카니발을 연상시키고, 또 키치적 아우라도 물씬 풍긴다. 이 작가의 이야기 수집벽이 남다른 것은 소설 몇 쪽만 들쳐보아도 충분히 알 수 있고, 더 읽어나가면 놀랄 수밖에 없게 된다”라고 평했다.

작가 자신, 우리의 지난 세기를 세상에 떠도는 얘기들로 채우고자 했다고 했지만, 그리고 이러저러한 잣대로 소설을 재단하는 것도 시도되고 있지만, 그보다는 우선 오랜만에 만나는 이야기의 성찬으로, 강력한 입심 앞에 선 독자가 느끼는 당연한 끌림에 순응해서 이 소설에 다가가는 것도 좋을 듯하다.